BIEN BOUGER À CHAQUE ÂGE

Sarcopénie : la fonte musculaire liée à l'âge n'est pas une fatalité

À partir d'un certain âge, nous perdons progressivement du muscle et surtout de la force. Les médecins ont un nom pour la forme la plus marquée de ce phénomène : la sarcopénie. Bonne nouvelle, c'est l'une des choses que l'entraînement combat le mieux.



80 ans +
le muscle progresse encore si on lui en donne une raison

FORCE

POUR NOS CLIENTS ACTIFS · 4 MIN DE LECTURE

01

Qu'est-ce que la sarcopénie ?

Le mot vient du grec sarx, la chair, et penia, le manque. En 2019, le groupe de travail européen sur la sarcopénie des personnes âgées a publié dans la revue Age and Ageing une définition révisée qui fait référence. Il y décrit la sarcopénie comme une maladie du muscle, caractérisée avant tout par une force musculaire faible, confirmée par une quantité ou une qualité musculaire diminuée. Quand les performances physiques sont aussi altérées, par exemple une marche lente, on parle de sarcopénie sévère.

Ce changement de définition est important : ce qui compte le plus, ce n'est pas seulement la taille des muscles, c'est leur force et leur capacité à te faire bouger.

02

Pourquoi c'est important

La perte de force musculaire a des conséquences très concrètes sur la vie quotidienne : difficulté à se lever d'une chaise, à monter des escaliers, à porter ses courses, à se rattraper en cas de déséquilibre. Elle augmente le risque de chutes, de fractures, de perte d'autonomie et d'hospitalisation.

Le groupe européen souligne aussi que la sarcopénie ne concerne pas que les personnes très âgées : ses racines se trouvent dans les changements musculaires qui s'accumulent tout au long de la vie, et elle peut apparaître plus tôt, notamment en cas de sédentarité, de maladie chronique ou de dénutrition.

> **Ce qui compte le plus, ce n'est pas la taille des muscles, c'est leur force et leur capacité à te faire bouger.**

03

Les facteurs qui l'accélèrent

- L'inactivité physique et la sédentarité : un muscle qui ne travaille pas fond.
- Les périodes d'alitement ou d'hospitalisation, même courtes.
- Une alimentation insuffisante, notamment en protéines et en énergie.
- Certaines maladies chroniques et l'inflammation.
- Les changements hormonaux liés à l'âge.

04

Le remède numéro un : le renforcement musculaire

C'est le message central de toutes les recommandations : l'exercice, et en particulier le renforcement musculaire, est la stratégie la plus efficace pour prévenir et ralentir la sarcopénie. Le muscle reste capable de progresser à tout âge, y compris chez les personnes de plus de 80 ans, à condition de lui donner une stimulation suffisante et progressive.

L'Organisation mondiale de la santé recommande à tous les adultes du renforcement musculaire au moins deux jours par semaine, et aux personnes âgées des activités variées qui associent force et équilibre au moins trois jours par semaine.

Une méta-analyse de 2017 publiée dans Sports Medicine a par ailleurs montré que, chez les personnes âgées, les programmes d'entraînement supervisés donnaient de meilleurs résultats sur la force et l'équilibre dynamique que les programmes réalisés en autonomie à la maison, à assiduité égale. L'encadrement compte.

05

À quoi ressemble un bon programme ?

- Deux à trois séances par semaine.
- Des exercices qui sollicitent les grands groupes musculaires, en priorité les jambes et les hanches : se lever d'une chaise, squats, fentes, montées de marches, presse, tirages, développés.
- Une intensité suffisante : les dernières répétitions de chaque série doivent demander un vrai effort, tout en gardant une bonne technique.
- Une progression régulière de la charge ou de la difficulté.
- Des exercices d'équilibre et de puissance, c'est-à-dire de vitesse, comme se lever rapidement d'une chaise, pour aider à se rattraper en cas de déséquilibre.

> **Le muscle reste capable de progresser à tout âge, même après 80 ans, si on lui en donne une raison.**

06

L'assiette, l'autre moitié du traitement

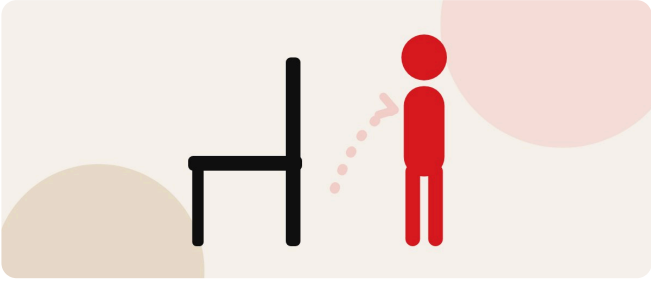
Le muscle a besoin de matériaux pour se construire.

- Des protéines en quantité suffisante. L'Anses retient une référence d'environ 1 gramme par kilo et par jour pour les personnes âgées, un peu plus que pour les adultes plus jeunes.
- Des protéines à chaque repas, y compris au petit-déjeuner, souvent pauvre en protéines.
- Assez d'énergie : les régimes restrictifs après 65 ans peuvent accélérer la perte musculaire, sauf avis médical.
- De la vitamine D, importante pour le muscle et l'os.

07

Les petits tests pour s'évaluer

Le groupe européen propose plusieurs tests simples utilisés par les professionnels, comme la force de préhension ou le temps nécessaire pour se lever cinq fois d'une chaise sans les mains. Tu peux faire ce dernier à la maison, avec prudence et une chaise stable contre un mur : chronomètre-toi pour te lever et t'asseoir cinq fois, bras croisés sur la poitrine. Refais le test tous les trois mois pour suivre tes progrès. Si tu as des difficultés importantes, parles-en à ton médecin.



Le test du lever de chaise

08

Ce que je te propose

On peut intégrer ces exercices dans ton programme, avec une progression adaptée, et suivre tes performances dans l'appli au fil des mois. Voir sa force augmenter, à n'importe quel âge, est l'une des plus belles motivations qui soient.

À RETENIR

- La sarcopénie est définie avant tout par une baisse de la force musculaire.
- Elle augmente le risque de chutes, de fractures et de perte d'autonomie.
- Le renforcement musculaire est la stratégie la plus efficace pour la prévenir et la ralentir.
- Les programmes supervisés donnent de meilleurs résultats chez les personnes âgées.
- Protéines à chaque repas et apports suffisants complètent l'entraînement.

SOURCES

- Cruz-Jentoft A.J. et al., Sarcopenia: revised European consensus on definition and diagnosis, Age and Ageing (2019) : https://doi.org/10.1093/ageing/afy169
- Lacroix A. et al., Effects of Supervised vs. Unsupervised Training Programs on Balance and Muscle Strength in Older Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis, Sports Medicine (2017) : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28573401/
- Organisation mondiale de la santé, Lignes directrices de l'OMS sur l'activité physique et la sédentarité, en un coup d'œil (2020) : https://www.who.int/fr/publications/i/item/9789240014886
- Anses, Protéines : rôle, sources et apports recommandés : https://www.anses.fr/fr/content/proteines-role-sources-et-apports-recommandes